ABDOMEN AGUDO II

DR. GERARDO VICTORIA

OBSTRUCCIÓN INTESTINAL

- ¿Existe obstrucción? ¿Dónde está? ¿Cuál es la causa?
- ¿Hay isquemia o estrangulación? Es la pregunta que cambia la conducta y la urgencia.
- Dolor cólico que se vuelve continuo: isquemia o estrangulación hasta demostrar lo contrario.

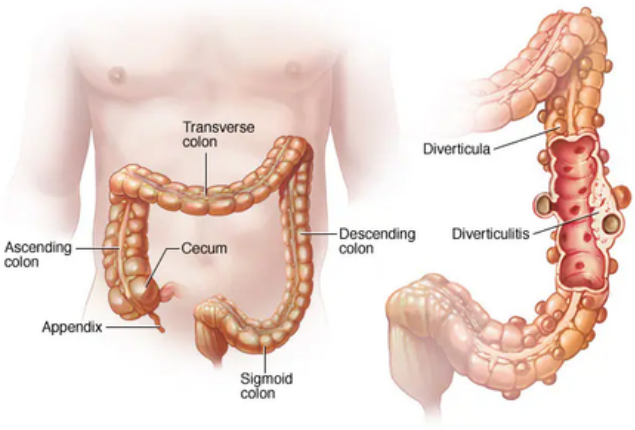
OBSTRUCCIÓN EN LA TC

- Asas proximales dilatadas, distales colapsadas, punto de transición y asa cerrada.
- Isquemia: edema mesentérico/líquido libre, menor realce, neumatosis o gas portal → urgencia quirúrgica.

OBSTRUCCIÓN ADHESIVA

- Observar si está estable, sin peritonitis ni isquemia: NPO, líquidos, electrolitos, descompresión y vigilancia seriada.
- Operar si hay peritonitis, asa cerrada, estrangulación, perforación, deterioro o fracaso del manejo.

DIVERTICULITIS AGUDA



- No complicada: inflamación localizada sin absceso, perforación libre, obstrucción ni fístula; manejo selectivo.
- Complicada: absceso, perforación, peritonitis, fístula u obstrucción; antibióticos, drenaje, cirugía o combinación.
- La TC clasifica y cambia la conducta; individualizar por severidad, comorbilidad e inmunosupresión.

ISQUEMIA MESENTÉRICA AGUDA

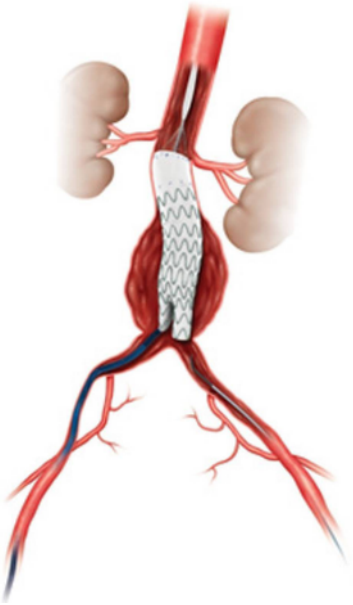
- Dolor intenso desproporcionado al examen; fibrilación auricular o aterosclerosis.
- El lactato puede elevarse tardíamente; angio-TC en el paciente estable.
- Peritonitis = posible necrosis intestinal; no esperarla para sospechar.

PANCREATITIS AGUDA

- Diagnóstico (2 de 3): dolor típico, lipasa/amilasa >3 veces el límite, imagen compatible.
- Analgesia, fluidos racionales y nutrición enteral precoz; buscar etiología y gravedad.
- Sin antibióticos profilácticos en la pancreatitis estéril.

AAA ROTO

- Varón mayor, tabaquismo, dolor lumbar o abdominal, síncope, hipotensión; la masa pulsátil no siempre está.
- POCUS detecta el aneurisma; TC con contraste solo si está estable.
- Activación vascular, control de hemorragia y reparación abierta o EVAR.



ABDOMEN AGUDO II

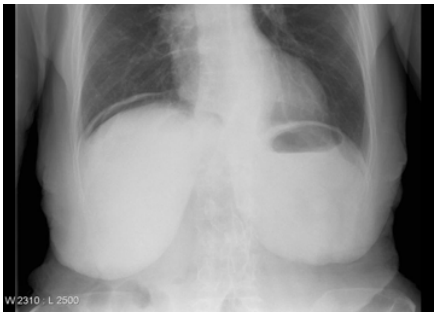
DR. GERARDO VICTORIA

PERFORACIÓN DE VÍSCERA HUECA

- Neumoperitoneo: aire fuera de la luz intestinal.
- Dolor súbito, irritación peritoneal, aire y líquido libre; sepsis si evoluciona.
- Causas: úlcera péptica, diverticulitis, tumor, isquemia, cuerpo extraño, iatrogenia o trauma.
- No basta con antibióticos si el foco no está controlado.

ÚLCERA PÉPTICA PERFORADA

- ABC, accesos IV y cristaloides según respuesta.
- Antibióticos de amplio espectro y analgesia.
- SNG según caso, IBP IV, laboratorio y reserva sanguínea.
- Imagen si está estable; cirugía urgente si hay peritonitis o inestabilidad.
- Cierre laparoscópico o abierto ± parche según contexto.



CONTRASTE HIDROSOLUBLE

- Puede tener valor diagnóstico y pronóstico en la obstrucción adhesiva seleccionada.

ALGORITMO DE LA DIVERTICULITIS

- La TC confirma el diagnóstico.
- No complicada: manejo ambulatorio u hospitalario según dolor, tolerancia oral y riesgo; antibióticos selectivos.
- Complicada: antibióticos, drenaje percutáneo si hay absceso; cirugía si hay peritonitis, sepsis, fracaso o perforación libre.

PANCREATITIS GRAVE

- Estrategia escalonada: soporte, vigilancia de falla orgánica, tratamiento de la causa biliar y manejo tardío de la necrosis infectada.
- No hacer TC temprana indiscriminada si el diagnóstico ya está claro.

PACIENTE INMUNOSUPRIMIDO

- Trasplante, quimioterapia, corticoides, biológicos, neutropenia, VIH avanzado.
- Menos fiebre, leucocitosis y signos peritoneales; evolución más rápida.
- «Sin fiebre» no significa «sin abdomen quirúrgico»: imagen con menor umbral.

EMBOLIA ARTERIAL MESENTÉRICA

- Inicio súbito; fuente cardíaca frecuente; afecta la AMS.
- Revascularización urgente y evaluación de la viabilidad intestinal.

TROMBOSIS ARTERIAL MESENTÉRICA

- Aterosclerosis previa; puede anteceder dolor posprandial o pérdida de peso.
- Puede requerir revascularización compleja.

ISQUEMIA NO OCLUSIVA (NOMI)

- Por bajo flujo, shock o vasopresores.
- Mejorar la perfusión, retirar la vasoconstricción y valorar intervención.

TROMBOSIS VENOSA MESENTÉRICA

- Dolor más insidioso; anticoagulación, estudio de trombofilia y cirugía si hay peritonitis o necrosis.

DIAGNÓSTICOS EXTRAABDOMINALES

- IAM inferior: epigastralgia, náuseas, diaforesis.
- Neumonía basal: dolor alto, fiebre, tos, hipoxia.
- Cetoacidosis: dolor difuso, vómitos, acidosis.
- Zóster, crisis falciforme e intoxicaciones (opioides, metales).

PACIENTE ANCIANO

- Menos dolor, fiebre y defensa; leucocitos a veces normales.
- Más isquemia, perforación, obstrucción, malignidad, AAA y sepsis.
- Un examen benigno no equivale a enfermedad benigna; umbral más bajo para imagen y observación.

EMBARAZO

- Diferencial doble: apendicitis, colecistitis, obstrucción, pancreatitis + ectópico, torsión, desprendimiento, trabajo de parto.
- Ultrasonido y RM; TC si el beneficio supera el riesgo.
- No retrasar la cirugía necesaria: la sepsis aumenta el riesgo materno-fetal.